

儿童急性上呼吸道感染诊疗指南

一、疾病定义与病因

1.1 疾病定义

急性上呼吸道感染（AURI），俗称“感冒”，是鼻腔、咽或喉部急性炎症的总称。它是儿童时期最常见的感染性疾病，年均发病 6-8 次，婴幼儿可达 10 次以上。绝大多数由病毒引起，具有自限性，一般 5-7 天痊愈。

1.2 主要病因

病原体分类	常见病原	占比
病毒性（90%以上）	鼻病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、流感病毒、副流感病毒、腺病毒	>90%
细菌性	A 组 β 溶血性链球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌	10% 左右，感染
支原体/衣原体	肺炎支原体、肺炎衣原体	较少见
诱发因素：受凉、过度疲劳、营养不良、维生素 D 缺乏、被动吸烟、气候突变、人群拥挤环境。		

二、典型症状与体征

2.1 普通感冒（最常见的上呼吸道感染）

- 局部症状：鼻塞、流涕（初期清水样，2-3 天后变稠）、打喷嚏、咽干咽痛、咳嗽。
- 全身症状：婴幼儿可伴发热（多为低至中度热）、烦躁不安、食欲减退；年长儿全身症状较轻。
- 体征：咽部充血、扁桃体肿大，颌下淋巴结可轻度肿大压痛。

2.2 特殊类型上感

类型	病原体	典型表现
疱疹性咽峡炎	柯萨奇 A 组病毒	高热、咽痛剧烈，咽峡部灰白色疱疹、溃疡。夏秋季高发。
咽-结合膜热	腺病毒 3、7 型	高热、咽炎、单侧或双侧滤泡性结膜炎（眼红、流泪）。春夏季高发。
流感	流感病毒	起病急、全身症状重（高热、乏力、肌肉酸痛），呼吸道症状较轻。

三、诊断标准与检查方法

3.1 诊断标准

根据典型症状（鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽）及体格检查（咽部充血），临床即可诊断。一般无需特殊检查。但需注意与流感、过敏性鼻炎、急性传染病早期（如麻疹、猩红热）鉴别。

3.2 辅助检查

检查项目	目的与临床意义
血常规	病毒性感染白细胞正常或偏低，淋巴细胞比例升高；细菌感染白细胞和中性粒细胞升高。
C 反应蛋白（CRP）	细菌感染时显著升高，病毒性正常或轻度升高。
病原学检查	咽拭子快速抗原检测（流感、RSV、腺病毒、A 组链球菌），指导针对性治疗。
胸片	若咳嗽持续 >1 周或肺部闻及湿啰音，需排查下呼吸道感染。

四、治疗方案（包括常用药物）

4.1 治疗原则

病毒性上呼吸道感染以对症治疗、休息、护理为主，不常规使用抗生素。

4.2 对症治疗

症状	处理措施及药物
发热	体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 或伴明显不适时，口服布洛芬或对乙酰氨基酚。WHO 推荐首选对乙酰氨基酚。
鼻塞、流涕	生理盐水喷鼻/洗鼻，婴幼儿可用吸鼻器清除分泌物。不推荐 6 岁以下儿童使用复方感冒药（含减充血剂、抗组胺药、解热镇痛药、黄碱、氯苯那敏）。
咽痛	年长儿含服润喉片，淡盐水漱口。
咳嗽	轻微咳嗽无需用药；咳嗽剧烈影响睡眠时，可雾化吸入布地奈德或口服氨溴索祛痰。禁用镇咳药。

4.3 抗病毒治疗

- 流感：确诊或高度疑似流感，应在发病 48 小时内 口服奥司他韦（每次 2-5mg/kg，每日 2 次，疗程 5 天）。
- 普通感冒无特效抗病毒药，利巴韦林不常规推荐。

4.4 抗生素使用指征

仅当明确或高度怀疑细菌感染时使用，主要指征包括：

- 持续高热不退，血常规示白细胞和中性粒细胞显著升高，CRP $>30\text{mg/L}$ 。
- 化脓性扁桃体炎（扁桃体有脓苔）、急性中耳炎、急性鼻窦炎。
- 常用药物：阿莫西林或阿莫西林克拉维酸钾，疗程 7-10 天。

五、家庭护理与预防建议

5.1 家庭护理要点

1. 充分休息：保证睡眠，减少活动，有利于体力恢复。
2. 补充水分：多饮温水、稀释果汁，防止脱水，利于排痰。
3. 清淡饮食：给予易消化、营养丰富的食物，如粥、烂面条、蒸蛋羹。
4. 保持室内环境适宜：温度 $20-22^{\circ}\text{C}$ ，湿度 50-60%，减少对呼吸道刺激。
5. 病情观察：若发热超过 3 天、精神萎靡、呼吸急促、耳痛、皮疹，立即复诊。

5.2 预防措施

1. 疫苗接种：每年秋季接种流感疫苗（6 月龄以上儿童），肺炎链球菌疫苗、Hib 疫苗可降低继发细菌感染风险。
2. 增强抵抗力：均衡营养、充足睡眠、每日户外活动。
3. 避免交叉感染：感冒流行季戴口罩，勤洗手，避免去人多拥挤处。
4. 注意保暖：随气温变化增减衣物，避免受凉，尤其是腹部和足部保暖。